

### 1) Introducción y relevancia clínica

Los **cuerpos extraños (CE) en nariz y oído** son una causa muy frecuente de consulta en **urgencias pediátricas** y en **APS**. Ocurren sobre todo entre los **2 y 6 años**, edad de exploración activa y menor juicio del riesgo. Aunque la mayoría se resuelve sin complicaciones, **una extracción inadecuada puede provocar sangrado, infección, perforación timpánica o aspiración a vía aérea**. Existen, además, **situaciones tiempo-dependientes** potencialmente graves, como **pilas tipo botón** y **imanes múltiples**, que requieren **retiro inmediato**.

Por qué es relevante para EUNACOM:

- Reconocer **presentaciones típicas: rinorrea purulenta unilateral y fetidez (nasal), otalgia y sensación de oído tapado (ótico)**.
- Conocer **técnicas seguras de extracción** en APS y **criterios de derivación a ORL/anestesia**.
- Identificar **contraindicaciones de irrigación** (p. ej., materia orgánica en CAE, perforación timpánica, pilas).
- Manejar **analgesia, inmovilización, sedación mínima y cuidados posteriores**.

---

### 2) Fisiopatología y bases conceptuales

#### 2.1 ¿Por qué se impactan?

- **Nasales**: los objetos se alojan en el **meato inferior** o sobre el piso nasal, retenidos por **edema mucoso**, **secreción** y la convergencia de **cornetes**.
- **Óticos**: el **conducto auditivo externo (CAE)** es curvo y con **piel delgada sobre hueso** en su tercio medial; la **cera** y el **edema** “sellan” objetos redondos (cuentas), mientras que los **materiales orgánicos** (porotos, maíz) **se hinchan** con el agua, aumentando el enclavamiento.

#### 2.2 Riesgos específicos

- **Pilas botón:** generan **lesión cáustica** por corriente y alcalinización de contacto; en nariz pueden producir **necrosis septal** en horas; en CAE, **necrosis del conducto y membrana timpánica**.
  - **Imanes múltiples:** pueden **pinzar el tabique** (uno por cada fosa) o **atraerse a un piercing**, causando isquemia local.
  - **Insectos vivos en CAE:** causa **otalgia intensa y vértigo**; conviene **inmovilizarlos** antes de extraer.
- 

### 3) Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

#### 3.1 Cuerpo extraño nasal

- **Rinorrea mucopurulenta unilateral y fétida** (dato clásico).
- **Epistaxis leve, obstrucción, estornudo, prurito.**
- **Tos por goteo posterior;** en lactantes, irritabilidad.
- Hallazgo en examen: **objeto visible** en meato inferior o medio; mucosa edematosa con costras.
- **Sospechar pila** ante **necrosis negra, quemadura local, dolor importante o evolución muy rápida.**

**Diagnóstico diferencial nasal:** rinitis purulenta unilateral (cuerpo extraño oculto), sinusitis maxilar, rinitis alérgica (suele ser bilateral y pruriginosa), pólipos (raro en niños).

#### 3.2 Cuerpo extraño ótico (CAE)

- **Otalgia, hipoacusia de conducción, plenitud, tinnitus; otorrea** si sobreinfección.
- Niños pequeños: **manotean la oreja**, irritabilidad.
- **Insecto:** dolor súbito, **zumbido**; a veces nistagmo o náuseas si estimula pared ósea.
- Examen: **objeto visible** con otoscopia; valorar **integridad timpánica, edema y sangrado.**

**Diagnóstico diferencial ótico:** otitis externa (dolor a la tracción del pabellón), tapón de cerumen, micosis (hifas), colesteatoma (otorrea crónica fétida), perforación timpánica.

---

## 4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

- El diagnóstico es clínico (inspección/otoscopía/rinoscopía anterior).
- No se requieren imágenes de rutina.
- Rx solo si se sospecha aspiración o ingesta concomitante (monedas/pilas) o en objetos radiopacos que no se visualizan.
- No usar contrastes ni irrigaciones diagnósticas nasales.
- Si hay sangrado importante, no cooperador o objeto no visible, derivar a ORL.

Confirmación de “pila botón” (si duda): su apariencia metalizada y depósito necrótico local; no demorar el retiro esperando exámenes.

---

## 5) Tratamiento (según práctica en Chile / enfoque MINSAL-APS)

### 5.1 Reglas generales

1. **Explicar y contener:** equipo entrenado, **inmovilización suave** (envoltura tipo “burrito” en lactantes), **analgesia** (paracetamol/ibuprofeno) y **ansiólisis leve** si es posible (midazolam intranasal u oral en algunos centros).
  2. **Iluminación adecuada y visualización directa:** otoscopio/otoscopio con espéculo apropiado; aspiración fina si secreción.
  3. **Máximo 1–2 intentos** en APS: **intentos repetidos** aumentan edema, sangrado y fracaso.
  4. **Criterios de derivación temprana** (ver más abajo): **pila, imán, objeto punzante, en contacto con tímpano**, niño no cooperador, fracaso de un intento.
- 

### 5.2 Cuerpo extraño nasal — Técnicas de extracción

#### A. Maniobras de presión positiva (primera línea en APS)

- **“Beso del padre/madre”**: ocluir fosa nasal **contralateral**, **sellar la boca** del niño y soplar **suavemente** por 1–2 segundos, repetido 3–5 veces. Eficaz para objetos lisos en **meato inferior**.
- **Bolsas autoinflables/insuflación oral** (si disponible).

Ventajas: alta tasa de éxito, bajo riesgo; ideal antes de pinzas.

## B. Instrumental simple

- **Gancho en “J”** (alambre romo): pasar **más allá del objeto** (cuando se ve el borde posterior) y **traccionar hacia afuera** por el piso nasal.
- **Pinza de cocodrilo o bayoneta**: útil para **espumas o algodón**; **evitar** en objetos **redondos y lisos** (riesgo de empujarlos atrás).
- **Sonda Foley 6–8 Fr**: pasar **suave** rebasando el objeto, inflar **1–2 ml**, retirar lentamente (requiere experiencia).
- **Aspiración** con sonda flexible si el objeto es pequeño y **no se adhiere**.

## C. Vasoconstrictor / anestesia tópica

- **Oximetazolina o adrenalina diluida** en mecha para **decongestionar**.
- **Lidocaína tópica** (spray/gel) disminuye dolor y reflejos; precaución en lactantes.

## D. Lo que NO hacer

- **No irrigar** la nariz (riesgo de **broncoaspiración**).
- Si se **sospecha pila/imán**, **no maniobrar** repetidamente: **derivar urgente** si no sale al primer intento.

## E. Retiro de pilas botón / imanes (urgencia)

- Intento único con **gancho en J** o **Foley** + vasoconstrictor; si no sale **rápido**, **derivar a ORL** para extracción instrumental endoscópica.
- **Tiempo es tejido**: necrosis septal puede ocurrir en **<4–6 h**.

---

## 5.3 Cuerpo extraño ótico — Técnicas de extracción

**Decisión clave: tipo de objeto y estado del tímpano.** Antes de intervenir, **evaluar** si el niño **cooperará**; si **no**, **derivar** para extracción bajo sedación o anestesia corta.

#### **A. Irrigación templada (solo si está indicado)**

- Útil para **objetos inertes, lisos y pequeños** (cuentas, fragmentos de cera) **si el tímpano está íntegro y NO es materia orgánica**.
- **Contraindicaciones** de irrigación:
  1. **Perforación timpánica** conocida o sospechada.
  2. **Otitis externa** con dolor intenso.
  3. **Materia orgánica** (semillas, porotos) → **se hinchan**.
  4. **Pila botón**.
- Técnica: agua a **temperatura corporal**, chorro **lento dirigido a pared posterosuperior** del CAE, no directamente al objeto/tímpano.

#### **B. Extracción instrumental**

- **Ganchos romos / curetas**: rodear y traccionar **por detrás** del objeto.
- **Pinza de cocodrilo**: útil para **algodón, papel**, objetos con agarre.
- **Sonda Foley** (muy excepcional) o **suction** de baja presión para objetos pequeños.
- **Microscopio / otoscopio con espéculo** mejoran precisión.

#### **C. Insectos vivos**

- **Primero inmovilizar/matar** con **aceite mineral, glicerina o lidocaína al 2%** tibia en el CAE; luego extraer con **pinza o irrigación** (si tímpano íntegro).
- Evitar **alcohol** (doloroso) en CAE inflamado.

#### **D. Pilas botón / imanes en CAE (urgencia)**

- Intentar **rápida extracción** con **gancho/pinza** bajo **buena visualización**.
- **No irrigar**.

- Si difícil o el niño no coopera → **derivar inmediata** a ORL; riesgo de **necrosis y perforación timpánica** en pocas horas.

#### E. Cuándo detenerse

- Tras **1 intento fallido** o **sangrado/edema notable, alto y derivación**. Intentos repetidos **empeoran** el pronóstico.
- 

### 5.4 Criterios de derivación a ORL / urgencias hospitalarias

- **Paciente no cooperador** pese a contención y analgesia.
  - **Objeto no visible** o **más allá del ángulo** (profundo).
  - **Pila botón** o **imanes** (nasal/CAE).
  - **Objeto punzante/vidrio** o **en contacto con membrana timpánica**.
  - **Fracaso** en 1–2 intentos en APS.
  - **Sospecha de aspiración** o **deglución concomitante**.
  - **Complicaciones**: epistaxis que no cede, laceración importante, otorragia, vértigo.
- 

### 5.5 Manejo posterior y educación

- **Inspección post-extracción** para descartar **laceraciones, perforación** o restos.
- **Gotas óticas antibióticas** (quinolona) si hubo **excoriación** del CAE o **manipulación prolongada**; **no** usar combinaciones con neomicina si **perforación** posible.
- **Antibióticos sistémicos**: **no de rutina**; solo si hay **otitis externa, celulitis o sinusitis** concomitante.
- **Analgesia** según necesidad.
- **Tétanos**: evaluar **esquema** si hubo laceraciones significativas.

- Aconsejar a cuidadores: **no introducir cotonitos** ni objetos; supervisión y **bloqueo de acceso a pilas e imanes**.
- 

## 6) Complicaciones y pronóstico

### Nasales

- **Epistaxis**, rinitis/ sinusitis bacteriana.
- **Necrosis septal y perforación** (pila).
- **Aspiración** durante intentos fallidos.

### Óticas

- **Escoriaciones** de CAE, **otitis externa**.
- **Perforación timpánica**, **híperacusia**, **vértigo** (trauma del estribo).
- **Quemadura cáustica** por pila → necrosis, **estenosis** del CAE.

**Pronóstico:** excelente con extracción precoz y **pocos intentos**. El retraso en **pilas e imanes** eleva el riesgo de **secuelas**.

---

## 7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### ☐ Perlas clínicas

1. **Rinorrea purulenta fétida unilateral** en niño sano = **CE nasal** hasta demostrar lo contrario.
2. **Materia orgánica** en CAE **no se irriga**; **semillas** se **expanden** con agua.
3. **Pila botón** en nariz o CAE = **emergencia**: retiro **inmediato** (ideal <2–4 h).
4. **Beso del padre** es **primera línea** en CE nasal: seguro, efectivo, sin instrumental.
5. **1–2 intentos** en APS; si falla o hay **sangrado**, **derivar**.

6. **Insecto** en CAE: **matar primero** con aceite/lidocaína, **después** extraer.
7. **No irrigar** nariz; en oído, **solo si tímpano íntegro y objeto inerte**.

## **✗Errores comunes**

- Insistir con **múltiples intentos** y sin visualización → edema, sangrado, fracaso.
  - **Irrigar** una **semilla** en CAE o un **poco cooperador** con dolor intenso.
  - **Demorar** el retiro de **pila** esperando Rx o derivación sin aviso.
  - Extraer **a ciegas** con pinza en **nasofaringe** (riesgo de aspiración).
  - Olvidar **chequear tímpano** y **CAEs bilaterales** (a veces hay **más de un objeto**).
  - No indicar **control** cuando hubo **erosión** o **manipulación difícil**.
- 

## **8) Resumen final (5–7 ideas clave)**

1. **Cuerpos extraños nasales/óticos** son frecuentes en preescolares; el diagnóstico es **clínico**.
2. **CE nasal: rinorrea purulenta unilateral y fetidez**; técnica de “**beso del padre**” es primera línea.
3. **CE ótico: elegir irrigación solo con tímpano íntegro y objeto inerte**; en **materia orgánica, pila o perforación sospechada, no irrigar**.
4. **Pilas e imanes** son **emergencias**; retirar **de inmediato** o **derivar** sin retrasos.
5. Realizar **máximo 1–2 intentos** en APS; más intentos aumentan edema, sangrado y aspiración.
6. **Derivar a ORL** si niño **no coopera**, objeto **profundo/punzante, en contacto con tímpano**, o **fallo** del primer intento.
7. Tras la extracción, **revisar lesiones**, tratar **otitis externa** si procede, **no antibióticos sistémicos** de rutina, y reforzar **educación preventiva**.